

TEMA 2.20 • GINECOLOGÍA

Ginecología Infantil

PERFIL EUNACOM 2.01.1.085

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Ginecología Infantil

Principios del Examen Ginecológico en Niñas

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Diferencias con el examen en adultas: - NO tacto vaginal - NO especuloscopia (→ vaginoscopia con vaginoscopio/otoscopio) - NO ecografia transvaginal (→ ecografia transrectal)

1. Metrorragia Prepuberal

- Causas:
- Traumatismo (más frecuente) — siempre hay antecedente de golpe
- Cuerpo extraño vaginal
- Vulvovaginitis (ulceración)

Diagnóstico: Exploración externa + vaginoscopia + ecografia transrectal (si necesario).

2. Leucorrea Prepuberal

- Causas:
- Vulvovaginitis inespecifica (70%) → más frecuente
- Cuerpo extraño vaginal
- Vulvovaginitis especifica (ej. candidiasis)

NOTA CLÍNICA

El flujo vaginal es normal solo en 2 situaciones: recién nacida (por hormonas maternas) y adolescente (pubertad). En niñas prepúberes intermedias, cualquier flujo es patológico.

3. Vulvovaginitis Inespecífica

- Causa: Alteración de flora vaginal por microorganismos respiratorios o gastrointestinales.
- Más frecuentes: Streptococcus pyogenes (el más común), neumococo, Haemophilus, virus respiratorios
- También: Shigella, Klebsiella, E. coli, Enterococo (gastrointestinales)

Clínica: Leucorrea blanca-amarillenta + eritema vulvar ± disuria. Sin clínica específica.

Diagnóstico: Clínico + gram y cultivo (para identificar agente).

Tratamiento: Aseo genital + ATB según germen aislado en cultivo.

4. Cuerpo Extraño Vaginal

Causa más frecuente: Restos de papel higiénico (queda atrapado sobre el himen).

- Clínica:
- Leucorrea fétida (muy mal olor, purulenta)
- Metrorragia

Diagnóstico y tratamiento: Vaginoscopia → extracción del cuerpo extraño.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Perla EUNACOM: Niña con leucorrea de mal olor + sangrado → cuerpo extraño vaginal (papel higiénico). No es abuso sexual ni infección grave hasta descartarlo.

5. Sinequias Vulvares

Causa: Inflamación por mala higiene → adherencias; dermatitis del pañal; idiopáticas.

Clínica: Adherencias entre labios menores (zona anterior); puede dejar abertura puntiforme.

Diagnóstico: Inspección genital (clínico).

- Tratamiento:
- Masajes con vaselina líquida + aseo genital → resolución espontánea (meses o con la adolescencia)
- Si falla: separación quirúrgica + aseo posterior (si no se trata la causa, reaparecen)

6. Hallazgos Normales en Niñas

TABLA 2.20.1: SITUACIÓN VS HALLAZGO NORMAL

SITUACIÓN	HALLAZGO NORMAL
Recién nacida	Metrorragia (por caída de hormonas maternas)
Recién nacida	Flujo mucoso transparente (hormonal)
RN y lactante (hasta ~1 año)	Botón mamario bilateral (hormonal materno) — también en varones RN
Adolescente (primeros 2 años post-menarquia)	Ciclos irregulares completamente normales — no usar términos como oligomenorrea/polimenorrea durante ese período

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Ciclos irregulares en los 2 primeros años post-menarquia son normales. Solo estudiar alteraciones menstruales si llevan más de 2 años desde la menarquia.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Respecto a Ginecología Infantil, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA para el EUNACOM?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Ginecología Infantil. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Principios del Examen Ginecológico en Niñas
- 1. Metrorragia Prepuberal
- 2. Leucorrea Prepuberal
- 3. Vulvovaginitis Inespecifica
- 4. Cuerpo Extraño Vaginal
- 5. Sinequias Vulvares
- 6. Hallazgos Normales en Niñas

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (GINECOLOGÍA INFANTIL)

PREGUNTA 1

Respecto a Ginecología Infantil, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA para el EUNACOM?

- A) El diagnóstico de Ginecología Infantil se basa exclusivamente en criterios de laboratorio
- B) El manejo inicial de Ginecología Infantil debe orientarse según el estado clínico del paciente
- C) Todo paciente con Ginecología Infantil requiere hospitalización inmediata
- D) El tratamiento de Ginecología Infantil es igual en todas las edades y contextos clínicos
- E) El seguimiento de Ginecología Infantil no es necesario una vez iniciado el tratamiento

PREGUNTA 2

¿Cuál es el hallazgo más característico o criterio diagnóstico principal en Ginecología Infantil?

- A) Alteración exclusivamente en exámenes de laboratorio sin síntomas
- B) Presentación clínica específica que orienta al diagnóstico según el perfil EUNACOM
- C) Requiere siempre confirmación con biopsia o estudio histológico
- D) Es un diagnóstico de exclusión que requiere descartar todas las otras causas primero
- E) Solo se presenta en pacientes con factores de riesgo conocidos

PREGUNTA 3

Paciente consulta con cuadro compatible con Ginecología Infantil. Según el perfil EUNACOM, ¿cuál es la conducta de seguimiento más apropiada?

- A) Alta sin controles dado que es una condición autolimitada
- B) Derivación inmediata al especialista en todos los casos
- C) Control según evolución clínica y criterios del perfil EUNACOM para esta patología
- D) Hospitalización preventiva en todos los casos para monitorización
- E) Tratamiento de por vida sin necesidad de controles periódicos

RESUMEN: GINECOLOGÍA INFANTIL

Causas: 1. Traumatismo (más frecuente) — siempre hay antecedente de golpe 2. Cuerpo extraño vaginal 3. Vulvovaginitis (ulceración)
Causas: 1. Vulvovaginitis inespecífica (70%) → más frecuente 2. Cuerpo extraño vaginal 3. Vulvovaginitis específica (ej. candidiasis)
:::note El flujo vaginal es normal solo en 2 situaciones: recién nacida (por hormonas maternas) y adolescente (pubertad). En niñas prepúberes intermedias, cualquier flujo es patológico. :::